Oportunidad de negocio: software de gestión de turnos y control horario en el sector sanitario andaluz

Sí, existe una oportunidad de negocio real, pero NO está donde parece. El gran sistema público (SAS) ya tiene su propio software corporativo (GERHONTE) y acaba de licitar mejoras de planificación automática de turnos, por lo que ese segmento está cerrado a un competidor externo. La oportunidad genuina y desatendida está en el **sector sanitario y sociosanitario privado de Andalucía** —clínicas y hospitales privados, y muy especialmente las residencias geriátricas— donde la gestión de turnos sigue dominada por el papel y el Excel, la normativa de control horario aprieta cada vez más, y las soluciones genéricas del mercado no están adaptadas ni a los convenios provinciales andaluces ni a las ratios de personal del sector dependencia.

TL;DR

- **Hay oportunidad, pero el nicho es el privado/sociosanitario, no el SAS.** El SAS gestiona a más de 100.000 profesionales con su sistema propio GERHONTE (desarrollado por Ayesa) y ya está invirtiendo en planificación automática de turnos; competir ahí de frente es inviable. El hueco real está en ~59 hospitales privados, los grandes grupos (Quirónsalud, Vithas, HLA), miles de clínicas sin internamiento y, sobre todo, las ~636 residencias de mayores andaluzas con más de 40.000 trabajadores, donde aún predominan Excel y papel.
- **El dolor está documentado y la ley empuja.** El registro horario es obligatorio desde mayo de 2019 (RDL 8/2019, art. 34.9 ET), la Inspección rechaza sistemas manipulables como Excel/papel, y el Proyecto de Ley aprobado por el Consejo de Ministros el 6 de mayo de 2025 exige registro digital interoperable elevando la multa máxima de 7.500 € a 10.000 €, computada por cada persona trabajadora afectada. El sector combina la mayor complejidad horaria posible (turnos 24/7, guardias, noches, rotaciones, jornada anual irregular) con la menor madurez digital en la función de RRHH.
- **La diferenciación ganadora es la especialización local-normativa.** Una solución que incorpore de serie los convenios provinciales de sanidad privada y el convenio de dependencia, las ratios de personal de residencias por CCAA, la validación automática de descansos (12 h entre jornadas), el control del cómputo de jornada anual y guardias, y la exportación a nómina, batiría a los productos genéricos (Quinyx, Planday, Deputy) que no entienden la casuística española del sector.

Hallazgos clave

- **El sistema público andaluz NO está rezagado; está, en conjunto, a la vanguardia relativa de España.** El Índice Fenin de Madurez Digital en Salud (Fenin + Fundación Cotec) sitúa la madurez digital general de los servicios de salud españoles en un bajo 31,7 % (834 de 2.632 puntos), siendo el servicio más maduro el acceso de profesionales a la historia de salud, con un 60 %. Pese a esa media baja, Andalucía aparece entre las comunidades líderes: el Índice Ejecutivo de Grandes Sistemas Sanitarios Autonómicos (IEGSA) del Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicadas (21 de noviembre de 2025) la situó en 3.ª posición

nacional con 81 puntos sobre 100, tras Madrid (86) y País Vasco (84). El SAS ha presentado en 2026 una Estrategia de Salud Digital de 316,5 M€ y ha activado 17 proyectos de digitalización. Conclusión: el problema andaluz no es "atraso" general, sino **desigualdad por ámbitos** —lo asistencial (historia clínica DIRAYA, receta electrónica) está muy maduro, mientras la gestión de personal y el control horario real son comparativamente débiles. Colegio Oficial Ingenieros ...

- **En el SAS, la gestión de turnos ya está informatizada vía GERHONTE, pero con un punto débil crítico: el registro horario REAL de los médicos.** GERHONTE (módulo "Turnos y Absentismo") gestiona la plantilla del SAS, y unos 70.000 profesionales descargan ya su nómina vía la app mGerhonte, pero los sindicatos médicos denuncian que las horas efectivas —especialmente guardias y guardias localizadas— no se registran de forma fiable. El Sindicato Médico Andaluz lo expresa con crudeza respecto a las guardias localizadas: "Ni siquiera se le consigna el tiempo trabajado en el sistema informático a efectos de cómputo de jornada". Esto deja al colectivo médico (el más caro y el de jornada más compleja) sin un control horario que cumpla el espíritu del RDL 8/2019, un agujero que la propia Administración reconoce. Smandaluz
- **El nicho desatendido y rentable es el privado-sociosanitario.** ~59 hospitales privados en Andalucía (Catálogo Nacional de Hospitales), miles de clínicas sin internamiento, y ~636 residencias geriátricas con más de 40.000 trabajadores del sector cuidados. Aquí la planificación de cuadrantes sigue haciéndose en Excel/papel, lo que es ilegalizable de facto por la Inspección y altamente ineficiente. Buscadorderesidencias CCOO Sanidad
- **La normativa es un viento de cola potente.** Registro diario obligatorio desde el 12/05/2019; conservación 4 años; Inspección que rechaza Excel/papel por manipulables; y un Proyecto de Ley (Consejo de Ministros 6/5/2025) que exigiría registro digital interoperable con sanciones de hasta 10.000 € por trabajador. En sanidad privada, además, los convenios provinciales fijan descansos de 12 h entre jornadas, preavisos de cuadrante de 7 días y jornadas anuales en reducción (de 1.826 h hacia 1.734 h en Huelva).
- **El mercado de software existe pero está mal ajustado.** Quinyx, Planday, Deputy, Shiftbase y Kronos son potentes pero genéricos (retail/hostelería) y no traen de serie los convenios sanitarios españoles ni las ratios de residencias. Empiezan a aparecer players especializados (aTurnos, Plain, ResiTurn, MHP, Timer Check) que validan la tesis del nicho, pero el segmento sociosanitario andaluz sigue lejos de estar consolidado.

Análisis detallado

1. Situación digital del sector sanitario andaluz

Andalucía no encaja en el cliché del "sur rezagado". En la asistencia clínica el Sistema Sanitario Público de Andalucía es de los más maduros de España: su historia clínica electrónica DIRAYA, la receta electrónica (Receta XXI), Salud Responde y la app Salud Andalucía/ClicSalud+ son referentes nacionales. En 2026 la Junta presentó la **Estrategia de Salud Digital de Andalucía (ESDA)** con una inversión de al menos 316,5 M€ a cinco años y el lanzamiento de la tarjeta sanitaria virtual, declarándose "pionera en España". El IEGSA del Instituto Coordenadas

(noviembre de 2025) colocó a Andalucía en **3.ª posición nacional (81/100)** en eficiencia, innovación y transformación, solo por detrás de Madrid (86) y País Vasco (84). Estetic

El matiz importante es que la madurez digital española en su conjunto es baja —el Índice Fenin/Cotec la cifró en **31,7** % de media nacional (834 de 2.632 puntos)— y es muy desigual entre ámbitos: el acceso de profesionales a la historia clínica alcanza el 60 % de madurez, pero los sistemas analíticos y de gestión interna se quedan muy por debajo. Es decir, **la digitalización andaluza es fuerte en lo asistencial y débil en lo organizativo/RRHH**, que es justo el terreno de la gestión de turnos. Colegio Oficial Ingenieros ...

El sector privado y, sobre todo, el sociosanitario (residencias) van claramente por detrás del público en digitalización de la gestión de personal. La Cámara de Cuentas de Andalucía, en su fiscalización de 2025 de las residencias de mayores, detectó incluso deficiencias de cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad e infrautilización de las herramientas digitales de coordinación.

2. Gestión de turnos y control horario en la sanidad andaluza

Sector público (SAS). Los turnos, guardias, atención continuada, permisos y vacaciones se gestionan en **GERHONTE** (GEstión de Recursos Humanos ONline con Tramitación Electrónica), el sistema corporativo único del SAS desarrollado por Ayesa, implantado al 100 % en hospitales, distritos y áreas de gestión sanitaria, que da cobertura a una plantilla de más de 100.000 profesionales. Tiene módulo específico "Turnos y Absentismo", app móvil mGerhonte (≈70.000 usuarios descargan su nómina por ella), y desde hace pocos años los profesionales pueden consultar online su "planilla" de horarios —una funcionalidad que SATSE llevaba años reclamando. GERHONTE arrastra, no obstante, una migración tecnológica iniciada en 2014 que mantiene dos versiones conviviendo (Gerhonte 1 y 2). Studocu Studocu

El punto crítico: GERHONTE gestiona la planificación y la nómina, pero **no actúa como un registro horario real de la jornada efectivamente trabajada** por los facultativos. Los médicos fichan poco o nada; sus horas de guardia y exceso de jornada no quedan trazadas de forma fiable.

Sector privado y residencias. Aquí domina lo manual. Los cuadrantes se elaboran en Excel o papel, con planillas que el convenio obliga a publicar con 7 días de antelación y a firmar entre empresa y representación sindical. La complejidad es máxima (turnos de mañana/tarde/noche, jornada partida, distribución irregular anual hasta 1.800 h, festivos especiales, descanso de 12 h entre jornadas) y el riesgo de error e incumplimiento, altísimo.

3. Software existente en el mercado

- **Soluciones genéricas internacionales (Quinyx, Planday, Deputy, Shiftbase, Kronos/UKG):** potentes en planificación por demanda e IA, pero diseñadas para retail y hostelería. No incorporan de serie los convenios colectivos sanitarios españoles, las guardias del Estatuto Marco ni las ratios de residencias. Planday se posiciona explícitamente como alternativa al Excel; Quinyx presume de +500.000 usuarios, pero su foco es retail.

- **Soluciones españolas de control horario/turnos (aTurnos, Plain, Factorial, Skello, Sage, TramitApp):** más cercanas a la normativa española (registro horario digital, alertas legales de descanso, exportación a nómina SAP/A3/Grupo Castilla). aTurnos y Plain ya apuntan a hospitales y residencias y calculan conceptos de nómina dependientes de la planificación (nocturnidad, festivos, guardias). Blink
- **Verticales sociosanitarios emergentes (ResiTurn, WeWorking, GestionDeResidencias, xpfConsulting):** el indicio más claro de que el nicho existe. ResiTurn, por ejemplo, se vende como software de cuadrantes "diseñado específicamente para residencias de mayores y centros geriátricos en España", con validación automática de coberturas mínimas por CCAA, descanso entre jornadas y contador de jornada anual (límite 1.800 h). Son aún pequeños y poco consolidados. Resiturn
- **Verticales sanitarios de control horario (MHP, Timer Check, ClinicBai):** orientados a clínicas privadas, diferencian guardias físicas y localizadas, gestionan jornadas que cruzan medianoche y multi-centro.
- **SAS:** desarrollo propio (GERHONTE) más una reciente licitación (contrato de 24 meses, importe superior a 12,7 M€) cuya novedad destacada es "la implementación de soluciones avanzadas para la planificación y gestión automática de turnos y jornadas laborales" — señal de que el propio SAS reconoce el déficit, pero también de que ese cliente se autoabastece.

4. Gaps y necesidades no cubiertas

1. **Registro horario real del personal médico (público y privado).** Es el agujero más documentado. El Sindicato Médico Andaluz denuncia que en guardias localizadas "ni siquiera se le consigna el tiempo trabajado en el sistema informático a efectos de cómputo de jornada". CSIF ha exigido formalmente que se implante software de control horario a los facultativos. Resultado: los médicos superan habitualmente las 48 h semanales (cómputo semestral) sin poder demostrarlo, en posible incumplimiento de la Directiva 2003/88/CE. Ceuta Actualidad + 2
2. **Adaptación normativa local.** Los productos genéricos no traen los convenios provinciales andaluces (Sevilla, Cádiz, Granada, Jaén, Huelva…) ni el convenio marco de dependencia, cada uno con su jornada anual, descansos y pluses específicos.
3. **Validación automática de ratios y coberturas mínimas en residencias.** Crítico porque el incumplimiento de ratios tiene consecuencias asistenciales (la propia CCOO documenta 1 gerocultor por cada 43 residentes de noche) y sancionadoras. CCOO Sanidad
4. **Gestión de sustituciones y bolsas de última hora.** En un sector con alto absentismo y temporalidad, asignar automáticamente la sustitución más adecuada (cualificación + disponibilidad + descanso legal) es un valor enorme aún mal resuelto.
5. **Integración fichaje ↔ planificación ↔ nómina.** Muchas herramientas separan fichaje, vacaciones y cuadrante, lo que convierte cada cierre de mes en "una reconstrucción forense".
6. **Equidad en el reparto de guardias.** UGT documenta quejas reiteradas por reparto "irregular y poco equitativo" de la jornada complementaria en atención primaria, sin

normativa que lo regule —un problema que un algoritmo transparente resolvería. Elsindicatoestuvoz

Normativa, tamaño de mercado y conclusión

5. Normativa relevante

- **RDL 8/2019, de 8 de marzo** (art. 10), que añade el **art. 34.9 del Estatuto de los Trabajadores**: obligación de registro diario de jornada para todas las empresas desde el **12 de mayo de 2019**, con hora concreta de inicio y fin, conservación **4 años** y disponibilidad para trabajadores, RLT e Inspección. Origen: sentencia del TJUE "caso Deutsche Bank" (C-55/18). La Inspección (criterio técnico 101/2019) exige trazabilidad e inalterabilidad y considera que **Excel/papel no cumplen** los requisitos de fiabilidad.
- **Reforma en tramitación (registro horario digital):** Proyecto de Ley aprobado por el Consejo de Ministros el **6 de mayo de 2025** (BOCG Serie A núm. 58-1, de 16/05/2025), que junto a la reducción de jornada introduce el **registro horario digital interoperable** accesible a la Inspección. El Dictamen del Consejo de Estado de 23/03/2026 cifró el coste inicial en 867 millones de euros (55,4 €/año por trabajador afectado, 1,35 millones de empresas y 15,6 millones de trabajadores) y la multa máxima sube de 7.500 € a **10.000 €, computada por cada persona trabajadora afectada**. Refuerza la urgencia de digitalizar.
- **Ley 55/2003, Estatuto Marco del personal estatutario:** regula jornada ordinaria, complementaria (guardias) y especial. Límite de 48 h semanales en cómputo semestral, ampliable hasta 150 h/año solo con consentimiento individual escrito. En el SAS la jornada ordinaria es de 1.540 h (turno diurno), 1.450 h (nocturno fijo) y 1.483 h (rotatorio) desde la implantación de las 35 h en 2017. Ceuta Actualidad SATSE Andalucía
- **Estatuto Marco en negociación (2024-2025):** foco de huelga médica; afecta a guardias (reducción de 24 a 17 h), guardias localizadas, cómputo de descansos y retribución. Cualquier solución de turnos debe ser fácilmente reconfigurable ante estos cambios. Infobae
- **Convenios colectivos provinciales de sanidad privada (Sevilla, Cádiz, Granada, Jaén, Huelva):** fijan jornada anual (p. ej., 1.784 h, reduciéndose), descanso de 12 h entre jornadas (a veces no compensable), descanso semanal de día y medio, preaviso de planilla de 7 días, pluses de nocturnidad y festivos especiales (24/25/31 dic, 1/6 ene) con recargos del 75 %. Iberley PSA CLUB
- **Convenio marco estatal de dependencia (residencias)** y normativa autonómica de acreditación de centros: jornada hasta 1.800 h, distribución irregular, ratios mínimas de personal y preaviso de cambios de 5 días. Resiturn

6. Tamaño de mercado (cuantificación)

Sector público (SAS) — grande pero cautivo:

- Plantilla del SAS: de 101.000 profesionales (2018) a ~130.000 (2025), de ellos >30.000 médicos y ~37.000 enfermeras.

- Red: ~1.500 centros de atención primaria (≈408 centros de salud + ~1.111 consultorios) y ~47–50 hospitales públicos. (Servicio Andaluz de Salud)
- **Conclusión: cliente único, con sistema propio (GERHONTE) y presupuesto para autoabastecerse. No es mercado abordable de forma directa.**

Sector privado — mediano y abordable:

- **~59 hospitales privados en Andalucía** (Catálogo Nacional de Hospitales, datos a 31/12/2023), con ~5.583 camas privadas.
- Grandes grupos con fuerte presencia regional: Quirónsalud (6 hospitales + 16 centros médicos, líder privado en Andalucía), Vithas y HLA (grupo Asisa), José Manuel Pascual Pascual, San Juan de Dios. (Quironsalud)
- Miles de clínicas y centros sin internamiento (cifra exacta a consultar en los registros REGCESS/SICESS).
- A nivel nacional, la sanidad privada emplea ~462.400 profesionales (2024, ASPE); Cataluña, Madrid y Andalucía concentran la mayoría. (El Español)

Sector sociosanitario (residencias) — el nicho más atractivo:

- **~636 residencias geriátricas** en Andalucía (fuente sectorial; ~62 % plazas públicas/concertadas, ~38 % privadas) y del orden de **80.000 plazas**; 40.200 plazas concertadas según la Junta. (Buscadorderesidencias + 2)
- **Más de 40.000 trabajadores** del sector cuidados/dependencia en Andalucía (CCOO Andalucía; convenio autonómico 2025), atendiendo a >169.000 personas usuarias.
- La Cámara de Cuentas (2025) cifra el ámbito público en 14 centros propios + 438 residencias concertadas coordinadas por ASSDA. (Ccuentas)
- Mercado fragmentado (muchos operadores medianos y pequeños), con alta rotación de personal, ratios obligatorias, presupuestos ajustados y casi nula digitalización de cuadrantes: **el perfil ideal de cliente de pago recurrente (SaaS) para un vertical especializado.**

7. Conclusión: ¿hay oportunidad y dónde?

Sí, hay oportunidad, y es nítida una vez se descarta el espejismo del SAS. El público es enorme pero está cubierto por GERHONTE y va a invertir en su propia planificación automática: intentar venderle a la Junta como startup es una vía larga, dependiente de licitación y de bajo retorno temprano. El verdadero océano azul es el **privado-sociosanitario andaluz**, donde converge la tormenta perfecta: obligación legal endurecida + métodos manuales (Excel/papel) + máxima complejidad de turnos + soluciones genéricas mal ajustadas + tejido fragmentado de centros con capacidad y necesidad de pagar por una herramienta que les quite riesgo sancionador y horas de gestión.

El nicho más desatendido: las residencias de mayores y los centros sociosanitarios, seguidos de las clínicas y hospitales privados medianos. **La diferenciación debe ser la especialización normativa local "out of the box":** convenios provinciales andaluces y de dependencia

precargados y mantenidos, validación automática de ratios de personal y descansos legales, control de cómputo de jornada anual y guardias, motor de sustituciones inteligente, fichaje móvil/biométrico antimanipulación, y exportación directa a nómina. Es exactamente lo que los gigantes genéricos (Quinyx, Planday, Deputy) no ofrecen, y donde un actor local con conocimiento del convenio y del cliente andaluz puede ganar.

Recomendaciones

Las recomendaciones se ordenan por fases, con los umbrales que deberían hacerte avanzar o pivotar.

Fase 1 — Validación del nicho (0-3 meses).

- **Empieza por residencias de mayores privadas y concertadas en Andalucía**, no por hospitales ni por el SAS. Realiza 20-30 entrevistas a directores/as y responsables de RRHH de residencias (grupos como Ballesol, DomusVi, Amavir y operadores locales) para confirmar: (a) que siguen usando Excel/papel, (b) cuántas horas/mes dedican al cuadrante, y (c) su miedo real a una sanción de Inspección.
- **Umbral de avance:** si >60 % usan Excel/papel y dedican >4 h/mes al cuadrante, el dolor es suficiente. Si la mayoría ya tiene un vertical (ResiTurn, aTurnos), reorienta hacia clínicas privadas medianas.

Fase 2 — Producto mínimo diferenciado (3-9 meses).

- Construye el MVP alrededor de la **única ventaja defendible: normativa local precargada**. Incluye de serie los convenios provinciales de sanidad privada de las 8 provincias andaluzas y el convenio de dependencia, con sus jornadas anuales, descansos de 12 h, preavisos y pluses.
- Funciones núcleo no negociables: generación automática de cuadrantes con validación de ratios y descansos, fichaje móvil antimanipulación (geolocalización/QR/biometría), contador de jornada anual en tiempo real con alertas, motor de sustituciones por cualificación + disponibilidad, y exportación a nómina (A3, Sage, SAP, Grupo Castilla).
- **Umbral:** 3-5 residencias piloto pagando (aunque sea precio reducido) antes de escalar comercial.

Fase 3 — Escalado y segundo segmento (9-24 meses).

- Expande a **clínicas y hospitales privados medianos**, donde el diferenciador adicional es el manejo de guardias físicas/localizadas y el registro horario médico —el agujero que ni el SAS resuelve—.
- Explora un módulo específico de "registro horario verificable de guardias" que pueda venderse incluso como complemento a centros que ya tienen otro RRHH.
- **Umbral de pivote/expansión:** con >30 centros de pago y churn <5 % mensual, plantea expansión a otras CCAA con convenios provinciales similares (Murcia, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha).

Sobre el SAS: no lo persigas como cliente directo de turnos (GERHONTE lo cubre). Si quieres entrar en lo público, hazlo como **proveedor especializado en un sub-problema concreto** (p. ej., registro horario verificable de facultativos/guardias) vía las licitaciones de mejora de RRHH que el SAS ya está sacando, no como sustituto del sistema.

Métricas a vigilar que cambian la estrategia: aprobación de la reforma de registro horario digital obligatorio (acelera toda la demanda); evolución del Estatuto Marco (redefine guardias y descansos, obliga a reconfigurar el producto); y movimientos de consolidación de los verticales emergentes (ResiTurn, aTurnos, Plain) que podrían cerrar la ventana de entrada.

Caveats

- **Cifras de residencias parcialmente de fuente secundaria.** El dato de ~636 centros y ~80.000 plazas procede de un portal sectorial (no oficial); las fuentes oficiales contrastadas confirman 40.200 plazas concertadas (Junta) y, en el ámbito público, 14 centros propios + 438 concertadas (Cámara de Cuentas, 2025). El total real incluyendo residencias puramente privadas debe verificarse en el registro autonómico. La cifra "más de 40.000 trabajadores del sector cuidados" está confirmada por CCOO y por el convenio autonómico de 2025. (Junta de Andalucía + 2)
- **Centros privados sin internamiento sin cifra exacta.** No existe un dato público desglosado y fiable solo para Andalucía del número de clínicas/consultas sin internamiento; habría que extraerlo de los registros REGCESS (Ministerio) y SICESS (Junta) filtrando por categoría y comunidad. Es un trabajo de campo previo recomendable antes de dimensionar ese subsegmento.
- **El marco normativo está en movimiento.** La reforma del registro horario digital es un Proyecto de Ley aún no aprobado definitivamente a fecha de este informe; sus cifras de coste y sanción proceden del dictamen del Consejo de Estado y podrían variar en la tramitación parlamentaria. Igualmente, el nuevo Estatuto Marco está en negociación conflictiva (huelgas médicas 2024-2025) y redefinirá guardias y descansos. Trátese como tendencia firme pero no como texto vigente cerrado.
- **El ranking de "eficiencia" no equivale a madurez digital de RRHH.** La 3.ª posición de Andalucía (Instituto Coordenadas, 2025) mide eficiencia y transformación globales del sistema, no específicamente la digitalización de la gestión de personal, que es donde se identifica el déficit. El Índice Fenin/Cotec, más específico de salud digital, es de 2020 (pre-COVID) y está pendiente de actualización.
- **Riesgo competitivo creciente.** La aparición de verticales españoles especializados (ResiTurn, aTurnos, Plain) indica que la ventana de oportunidad está abierta pero no será eterna; la ventaja defendible reside en la profundidad de la adaptación normativa local y el servicio, no en la tecnología de planificación en sí, que se está commoditizando.